

Dyspepsie fonctionnelle

Réalisé par Dr FERRIA
4eme année de médecine
Faculté de médecine de Constantine
2025-2026

PLAN

I .Introduction

II. Syndrome dyspeptique

Définition

Épidémiologie

III. Dyspepsie aiguë

IV. Dyspepsie chronique

Causes organiques

Dyspepsie fonctionnelle

V. Démarche diagnostique Clinique Examens complémentaires

VI. Options thérapeutiques

Traitement des causes organiques

Traitement de la dyspepsie fonctionnelle

VII. Conclusion

I-introduction

- La dyspepsie ou syndrome dyspeptique « mauvaise digestion »,
- motif très fréquent en consultation(MG ou gastro)
- causes nombreuses : organique ou fonctionnelle
- dyspepsie fonctionnelle ++++ 2/3
- Problème(indication des examens complémentaires (EDH)).
- Le traitement est celui des causes organiques ou de la dyspepsie fonctionnelle

II. Syndrome dyspeptique définition

- Le syndrome dyspeptique regroupe symptômes aigus ou chroniques récidivants type
- douleur épigastrique(brulure ++)
- Sensation de gêne ou inconfort , une pesanteur
- Satiété précoce
- manifestations associées : éructations ,nausées, vomissements occasionnels
- RGO et SII sont exclus

II. Syndrome dyspeptique épidémiologie

- sa prévalence dans population générale est d'environ 20 %
- un motif fréquent de consultation+++
- dyspepsie fonctionnelle 80 %

III-Dyspepsie aiguë

la survenue de symptômes dyspeptiques récents révélateurs des affections aiguës:

- **digestives:**
 - œsophagites infectieuses (candidose CMV) ou mé (AINS). RGO
 - les gastrites aiguës (HP.AINS)
- **Causes extradigestives:** l'ischémie myocardique, insuffisance rénale ,maladie systémique les pathologies endocrinienne ou métabolique

➤ **Œsophagiennes**

RGO (atypique) avec ou sans oesophagite peptique Cancer du cardia OEsophagites (à éosinophiles, etc.) Achalasie

➤ **Gastriques**

Gastrites chroniques (infection à *Helicobacter pylori*, *sarcoïdose*, etc.) Ulcères (*H. pylori*, *AINS*, *aspirine faible dose*, etc.) Néoplasies gastriques (adénocarcinome, lymphome, tumeur stromale) Anisakiase Gastroparésie (diabète, post-chirurgie, médicaments, idiopathique, etc.) Bézards

➤ **Intestinales**

Ulcère duodéal (*H. pylori*, *AINS*, *aspirine faible dose*, etc.) Maladie coeliaque
Parasitoses (lambliaze, anguillulose, ascaridiase, taeniasis, etc.)
Maladies inflammatoires (Crohn, gastroentérite à éosinophiles, etc.) Angor mésentérique
Intolérance au lactose

➤ **Hépatobiliaires**

Hépatites chroniques (virales, médicamenteuses, alcoolique, métaboliques, auto-immunes,
Lithiase biliaire, dysfonction du sphincter d'Oddi, dyskinésies biliaires
Cancers primitifs ou secondaires
Cholangiopathies inflammatoires, auto-immunes ;
Pancréatiques Pancréatites chroniques Cancers

➤ **Cardiovasculaires**

- Ischémie myocardique (angor atypique) ; Angor mésentérique Insuffisance cardiaque

➤ **Métaboliques** Diabète , Hypocalcémie

- **Endocrinienne** Dysthyroïdies Hyperparathyroïdies
- **Insuffisance rénale**
- **Insuffisance surrénalienne**
- **Maladies systémiques inflammatoires**
- **Neuropathies et myopathies** (gastroparésie)
- **Troubles psychiatriques**
- **Médicamenteuses** Particulièrement : acarbose, **antibiotiques** (métronidazole, macrolides, etc.), anti-Cox-2, **AINS, aspirine, bisphosphonates**, calcium, chlorure de potassium, **corticostéroïdes, fer, IEC**, inhibiteurs calciques, **IPP** (effet rebond à l'arrêt), **metformine**, miglitol, **estrogènes, opiacés**, orlistat, phytothérapie baies d'arbre, camomille, ail, ginkgo, etc.), **théophylline**, sildénafil, etc.

IV-Dyspepsie chronique

les symptômes évoluent depuis plus de 6 mois

- Le caractère chronique doit être établi
- Peut être dyspepsie organique ou fonctionnelle
- **la DF est la plus fréquente**

Dyspepsie fonctionnelle

La DF affecte jusqu'à 16 % des individus en bonne santé dans la communauté

les facteurs de risque:

- le sexe féminin
- l'antécédent de gastro-entérite aiguë ou l'installation brutale dans un contexte infectieux
- des comorbidités : psychiatriques ou fonctionnelles (fibromyalgie, syndrome de fatigue chronique),
- Le tabagisme, la consommation d'AINS

CRITERES DE DGC POSITIF (Rome IV)

Présence d'au moins l'un des éléments suivants
Plénitude postprandiale (≥ 3 jours par semaine)
Satiété précoce (≥ 3 jours par semaine)
Douleur épigastrique (≥ 1 jour par semaine)
Brûlure épigastrique (≥ 1 jour par semaine)

Les critères doivent être présents depuis au moins 3 mois, avec des symptômes commençant au moins 6 mois avant le diagnostic

2 sous groupe de DF

Syndrome de douleur épigastrique

Douleur Ou brûlures épigastriques
En lien ou non avec les repas

Syndrome de détresse postprandiale

Plénitude gastrique
Ou satiété précoce

CRITERES DE DGC NEGATIF(Rome IV)

aucune preuve de maladie structurelle

Sont exclus du cadre de la dyspepsie fonctionnelle les symptômes soulagés par l'émission de selles ou de gaz, les vomissements prédominants **SII**

Les éructations ;nausées et vomissement chronique ou cyclique ,RGO .SII

Physiopathologie de la DF

incomplètement comprise(multifactorielle)

- Dysfonctionnement de l'axe cerveau-intestin (des troubles de la motilité (dyskinésies),
- une hypersensibilité viscérale (en réponse à la distension gastrique)
- des anomalies hormonales digestives (cholécystokinine, oestrogène, progesterone etc.)
- des altérations du microbiote gastro-intestinal et de l'immunité muqueuse, inflammation de bas grade

V-Démarche diagnostique devant une dyspepsie

- **Rechercher les critères de(rome IV)**
- **Facteurs déclenchant :**(trouble du comportement alimentaire atypique, prise médicamenteuse, infection, etc.)
- **identifier signes d'alarme** pouvant orienter vers pathologie sévère digestive ou extra-digestive
- **une approche physiopathologique dans la DF**
- **Evaluer l'indication des examens complémentaires**
- **définir une stratégie thérapeutique.**

Signes d'alarmes et orientation diagnostique dans la dyspepsie	Possibles étiologies
âge ≥ 55–60 ans antécédent familial de cancer gastrique antécédent personnel d'ulcère gastroduodénal, sans preuve d'éradication de <i>Helicobacter pylori</i> prise chronique d'AINS perte de poids Vomissements persistants, hématemèse, méléna, anémie dysphagie progressive masse épigastrique palpable adénopathie sus-claviculaire gauche (Troisier)	Tumeur maligne digestive Ulcère gastroduodénal
Épigastralgie irradiant dans le dos Douleur de l'hypochondre droit Vomissements Ictère	Pathologies pancréatiques ou biliaires

Examens complémentaires

1) Endoscopie digestive haute de nécessité (limitée):

- les patients dyspeptiques âgés de plus de 55–60 ans systématique
- patients plus jeunes présentant des antécédents familiaux de cancer gastrique ou provenant d'une région à haut risque de ce cancer
- signes d'alarme d'une pathologie digestive sévère quelque soit l'âge
- **EDH doit être réalisée avec biopsies gastriques a la recherche hp et biopsies duodénales a la recherche de maladie cœliaque**

Examens complémentaires

2) Diagnostic non invasif de l'infection à « H. pylori » test respiratoire à l'urée

- patients jeunes âgés de moins de 60 ans, sans signes d'alarme dans une région à forte prévalence de cette infection

La réalisation de l'EDH reste optionnelle guidée par le résultat positif d'un test non invasif

Examens complémentaires

3) Traitement d'épreuve par anti sécrétoires:

- instaurer d'emblée un traitement d'épreuve anti sécrétoire gastrique par inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) ou anti-H₂
- En l'absence de réponse au traitement médicamenteux d'épreuve est une indication à l'EDH en seconde intention

Autres examens complémentaires

4)échographie ou TDM abdominale ou (IRM):

- écarter une autre cause digestive devant des signes d'alarme sans lésion à l'EDH.
- écarter une cause extradigestive devant Anomalies de bilan sanguin et hépatobiliaire

En l'absence de cause identifiable cela oriente vers le diagnostic de dyspepsie fonctionnelle

Exploration de la dyspepsie fonctionnelle

1) Mesure le temps de vidange: gastrique : 3 méthodes validées:

- la scintigraphie gastrique sur 4 heures (test de référence)
- la vidange gastrique par test respiratoire au ^{13}C ,
- la capsule à usage unique (SmartPill)

2) Manométrie gastrique (mesure la distensibilité)

3) pH-impédancemétrie (RGO atypique gazeux)

VI-Options thérapeutiques

1) Traitement des causes organiques: il est spécifique de la cause retrouvée .

- L'éradication de *H. pylori* *efficacité significative* chez les patients infectés
- épigastralgies prédominantes :IPP en cas AINS
- Le traitement des bézoards repose sur les techniques endoscopiques ou la dissolution

VI-Options thérapeutiques

2) Traitement de la dyspepsie fonctionnelle:

- **Relation médecin-malade;** fondamentale dans la prise en charge (écouter, expliquer, rassurer)
- **Regles hygienodiététique:**
 - Un régime alimentaire approprié est recommandé (éviter café ; lipides , sucres fermentescibles) en cas DF
 - un fractionnement alimentaire est envisageable en cas de détresse post-prandiale, gastroparésie

VI-Options thérapeutiques

Traitement de la dyspepsie fonctionnelle

- Le traitement médicamenteux les antisécrétoires gastriques (IPP ou anti-H2)
- les antidépresseurs imipraminiques (tricycliques) (amitriptyline ou clomipramine, 10–50 mg/j)
efficace pour le syndrome douloureux épigastrique
- La mirtazapine un effet analgésique central avec réduction de la sensibilité viscérale.

VI-Options thérapeutiques

Les prokinétiques

- antagonistes des récepteurs de la dopamine (dompéridone et métoclopramide) limité dans la dyspepsie chronique en raison des effets secondaire
- agonistes des récepteurs 5-HT₄,
- prise une demi-heure avant chaque repas,
- prescrit dans le syndrome de **détresse postprandiale**

Psychothérapies

- Les méthodes psychothérapeutiques (thérapie cognitivocomportementale, hypnose, etc.)
- **C'est un traitement optionnel recommandé en cas d'échec des médicaments.**

Thérapies complémentaires

- L'acupuncture décevante
- agents à base de plante **l'huile de menthe poivrée**

VII-conclusion

L'approche diagnostique de la dyspepsie est **clinique**

- Caractériser les symptômes et chercher des comorbidités.
- Les examens complémentaires sont guidées par les signes orientation(cause digestive ou extradiigestive)
- L'EDH n est **systématique** tout le temps mais reste l'examen essentiel pour identifier une lésion digestive haute et rechercher une infection gastrique à *H. pylori*.
- La prise en charge de la DF reste empirique, des mesures hygiéno diététiques, un soutien psychologique